Autos: 0817442-06.2018.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível - Serviços de Saúde (Planos de Saúde)
Autor:Donevil Teixeira Alvarez e outro
Réu: CASSEMS - Caixa de Assistência dos Servidores do Estado do Mato Grosso do Sul e outro

Vistos, etc.

Trata-se de ação pelo procedimento comum, proposta por **Donevil Teixeira Alvarez** em face de **Hospital Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul – CASSEMS e Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul - Plano de Saúde,** todos devidamente qualificados na inicial (f. 1-24).

Como base de sua pretensão, narra o autor, em síntese, ter sido internado no nosocômio réu em data de 20.01.2017, a fim de ser submetido a procedimento cirúrgico para reparação de ruptura do manguito rotador, cirurgia ortopédica considerada simples e realizada na região do ombro.

Salienta que por negligência, imprudência ou imperícia da equipe responsável pela cirurgia, um dos equipamentos utilizados no procedimento perfurou seu pulmão, fato que não foi percebido, de sorte que o ato prosseguiu normalmente.

Diz que após o término da cirurgia, quando já se encontrava na enfermaria, seu quadro clínico começou a piorar e ao ser submetido a exame de raio-x perceberam a existência de pneumotórax hipertensivo decorrente de perfuração pulmonar de grande volume, capaz, inclusive, de conduzi-lo à óbito.

Informa ter se submetido a nova cirurgia, destinada a colocação de dreno pleural, a fim de corrigir o erro médico a que foi exposto.

Assevera que os réus sempre foram evasivos quanto a situação vivenciada pelo autor, mormente porque negaram informações e não se predispuseram a reparar os danos causados.

Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na espécie, inclusive com vistas a inversão do ônus da prova.

Discorre sobre o erro médico configurado na situação analisada, bem assim acerca da responsabilidade civil dos réus pelo quanto ocorrido.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 18/03/2024 às 11:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817442-06.2018.8.12.0001 e código q1BDz5bV.

Tece considerações sobre a lesão extrapatrimonial experimentada e, ainda, quanto ao dever legal das rés em indenizá-lo.

Ao final, pede a condenação dos réus, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor correspondente a 200 (duzentos) salários mínimos.

Atribuiu valor à causa e juntou documentos (f. 25-210).

Às f. 289-300 o autor emendou a inicial, incluindo no polo ativo da presente demanda a esposa do autor, Sra. Angélica da Luz Barbosa Alvarez, uma vez que vivenciou momentos de intensa angústia e aflição decorrente do erro médico relatado nos autos.

Juntou documentos (f. 301-378).

Recebida a emenda à inicial (f. 379-382), sobreveio despacho inicial positivo apenas às f. 427.

Os réus apresentaram contestação em conjunto às f. 461-496, aduzindo, de pronto, não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor à plano de saúde de autogestão.

Em sede de preliminar, arguiram a ilegitimidade passiva *ad causam*, sustentando que a responsabilidade civil deve recair sobre a pessoa do médico, cuja natureza é pessoal, personalíssima e intransferível.

Obtempera sobre a responsabilidade civil do médico e a aplicação da teoria clássica da culpa.

Denuncia à lide o médico responsável pela cirurgia do autor, Dr. Regis Albertini.

Rebate a alegação de configuração de danos morais na situação retratada nos autos.

Ao final, requer a improcedência dos pedidos.

Juntou documentos (f. 497-551).

Impugnação à contestação às f. 553-566, ocasião em que a parte autora rebate as teses defensivas suscitadas pelos réus e, ainda, reforça o quanto pretendido em sua petição inicial.

Promove a juntada de novos documentos na oportunidade (f. 567-589).

Após a indicação de provas pelas partes, sobreveio a decisão de saneamento e organização do processo (f. 655-659), afastando a tese de ilegitimidade passiva das rés, bem assim a denunciação à lide pretendida. Na mesma oportunidade,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 18/03/2024 às 11:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817442-06.2018.8.12.0001 e código q1BDz5bV.

deferiu-se a produção de prova oral e pericial.

Laudo pericial encartado às f. 694-708, sobre o qual as partes se manifestaram às f. 711-717 (réus) e f. 729-732 (autores).

O laudo técnico foi complementado às f. 751-764 e f. 795-808, manifestando-se as partes em seguida (f. 812-815, autores e f. 816-817, reús).

Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.
Passo à fundamentação para, ao final, decidir.

Da desnecessidade de produção de prova oral

Muito embora no passado tenha sido determinada a produção de prova oral, tem-se que a oitiva de testemunhas se mostra absolutamente desnecessária ao deslinde da controvérsia trazida à apreciação jurisdicional.

Isso porque, a prova documental e pericial produzidas ao longo da instrução processual se revelam suficientes ao julgamento de mérito, mormente porque a convicção deste Juízo já se encontra devidamente formada. Outrossim, instadas a se manifestarem sobre isso, fls. 809, silenciaram as partes.

De mais a mais, aplica-se ao caso concreto a norma insculpida no art. 443, inc. II, do Código de Processo Civil, segundo a qual "*O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos: (...) II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados*".

Com efeito, a controvérsia trazida à apreciação jurisdicional diz respeito, justamente, à qualidade do serviço médico prestado, o que é devidamente apurado com o laudo pericial já encartado neste feito.

Em termos outros, a produção de prova oral tende apenas a retardar a resolução da questão controvertida, além do que, não infirmaria aquilo que se extrai das provas produzidas ao longo do feito, sobretudo da perícia técnica carreada ao presente feito.

Outrossim, o direito fundamental à tutela jurisdicional tempestiva também implica em um direito à prestação jurisdicional sem dilações indevidas, ou melhor, redunda na impossibilidade de o juiz adiar a concessão da tutela após ter formado seu convencimento. E o meu está pronto.

Finalmente, "*cabe salientar que a prova tem por destinatário o Juiz da causa, de forma a propiciar-lhe a formação de sua convicção. É neste aspecto, e na condição de dirigente do processo, que erige o poder do Juiz de limitar e excluir as provas consideradas manifestamente excessivas, impertinentes ou protelatórias"* (COSTA, Hélio Martins. Lei dos Juizados Especiais Cíveis anotada e sua interpretação jurisprudencial. Ed. Del Rey, 2000, pág. 208).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 18/03/2024 às 11:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817442-06.2018.8.12.0001 e código q1BDz5bV.

Por esta razão, tem-se por desnecessária a produção da prova oral.

Das preliminares e prejudiciais de mérito

Não há questões prejudiciais ou preliminares pendentes de análise, razão pela qual passa-se diretamente ao enfrentamento do mérito.

Registra-se, por absolutamente oportuno, ser prescindível, no caso em epígrafe, a intimação das partes para apresentação de memoriais escritos.

Com efeito, a ausência de intimação para a apresentação de alegações finais não caracteriza cerceamento de defesa, por se tratar apenas de oportunidade para que as partes reafirmem os argumentos discutidos no decorrer do processo.

A propósito, a intimação das partes para oferecimento de memoriais configura mera faculdade do julgador, que poderá determinar, ou não, a sua apresentação de acordo com a complexidade da matéria em debate, podendo ser dispensada caso o processo esteja maduro para julgamento, como revela ser a hipótese presente.

Sobre o tema, colaciona-se o seguinte julgado:

> *APELAÇÃO CÍVEL (...)* ***ALEGAÇÕES FINAIS - DESNECESSIDADE*** *- (...) Pode o juiz julgar antecipadamente o mérito com base nos documentos constantes dos autos, sem que isso configure cerceamento de defesa, mormente quando se mostra desnecessária a produção de outras provas para o desate da lide.* ***A oportunidade de apresentar alegações finais configura-se faculdade do juiz, que poderá determinar, ou não, a sua apresentação de acordo com a complexidade da matéria em debate, podendo ser dispensada caso o processo esteja maduro para julgamento****. (...)* (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.048256-0/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2020, publicação da súmula em 11/11/2020)

De mais a mais, a intimação para apresentação de alegações finais apenas retardaria a resolução definitiva da questão vertida na presente demanda, indo de encontro ao que estabelece os artigos 4º e 6º do Código Processual Civil quanto ao tempo razoável de tramitação do processo.

Passa-se, pois, à análise meritória.

Do mérito

Cuida-se de ação de reparação de danos decorrentes de suposto erro médico ocorrido em procedimento cirúrgico realizado nas dependências do primeiro réu (Hospital Cassems) e cujo gerenciamento incumbe ao segundo (plano de saúde).

Pretende-se, assim, a condenação dos réus ao pagamento de indenização moral, principalmente ante o risco de morte a que submeteram o primeiro

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 18/03/2024 às 11:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817442-06.2018.8.12.0001 e código q1BDz5bV.

autor após a realização de cirurgia em um de seus ombros.

É incontroverso que o autor se submeteu a procedimento cirúrgico, em data de 20.01.2017, destinada à reparação de ruptura do manguito rotador, procedimento ortopédico classificado como simples.

Também não é controvertido o fato de que durante o procedimento cirúrgico o autor sofreu a perfuração de um dos seus pulmões, fato que ocasionou seu encaminhamento à UTI e realização de nova intervenção médica, destinada a colocação de dreno pleural, de modo a conservar-lhe a vida.

Cinge-se, pois, a controvérsia em aferir se houve, ou não, erro médico no tratamento dispensado ao autor, bem assim, em caso positivo, se há danos morais passíveis de indenização.

Os pedidos são improcedentes.

De saída, é importante trazer à baila a lição de Nehemia Domingos de Melo em sua obra "*Responsabilidade Civil por Erro Médico*", destacando o que adiante segue:

> *"A natureza jurídica da prestação de serviços médicos, embora sui generis, é contratual, porém o profissional não se compromete com a obtenção de um determinado resultado, mas sim com prestar um serviço consciencioso, atento e de acordo com as técnicas científicas disponíveis, sendo assim uma típica obrigação de meios. Significa dizer que o médico não se obriga a restituir a saúde ao paciente que esteja aos seus cuidados, mas a conduzir-se com toda a diligência na aplicação dos conhecimentos científicos, para colimar, tanto quanto possível, aquele objetivo. Assim, a responsabilidade civil dos médicos, enquanto profissionais liberais, pelos danos causados em face do exercício de sua profissão, será apurada mediante aferição da culpa (imprudência, negligência ou imperícia), nos exatos termos do disposto no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90, art. 14, § 4º), e do Código Civil (Lei nº 10.406/02, art. 951)"* (Responsabilidade Civil por Erro Médico, Ed. Atlas, 2ª ed., 2013, pp. 96-97).

Tem-se, portanto, que a atividade médica não se obriga a alcançar a efetiva cura do paciente (justamente por não se tratar de uma obrigação de "resultado"), mas sim, a empregar todas as técnicas adequadas e exigidas na doutrina especializada que revelem um proceder de acordo com as regras e os métodos da profissão, destinados ao escopo primeiro desejado, qual seja, a recuperação da saúde ou reabilitação do paciente.

Não por outra razão, diz-se estar diante da chamada obrigação de "meio", em que o profissional médico precisa se valer dos meios necessários e adequados para alcançar a cura ou a reabilitação do enfermo.

O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, ao tratar da responsabilidade civil em seu obra, endossa o entendimento acima esposado, destacando que *"(...) o objeto do contrato médico não é a cura, obrigação de resultado, mas a prestação de cuidados conscienciosos, atentos, e, salvo circunstâncias excepcionais, de acordo com as aquisições da ciência. Comprometem-se os médicos a tratar o cliente com zelo, utilizando-se dos recursos adequados, não se obrigando, contudo, a curar o*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 18/03/2024 às 11:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817442-06.2018.8.12.0001 e código q1BDz5bV.

doente" (GONÇALVES, Carlos Roberto, ***Direito Civil Brasileiro, volume 4: Responsabilidade Civil,*** 7. ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 258).

Muito embora a pretensão condenatória dos autores não recaia diretamente sobre o profissional médico que realizou o procedimento cirúrgico trazido à apreciação jurisdicional, mormente porque ação manejada contra o hospital e o plano de saúde que o credencia, faz-se necessária apurar a efetiva existência do elemento "culpa" do médico, de modo a viabilizar a responsabilidade civil dos réus na hipótese sob exame.

Com efeito, ao comentar o art.951 do Código Civil, o doutrinador Gustavo Tepedino pondera o seguinte:

> *"A responsabilidade do profissional de saúde é subjetiva, nos termos do art. 951 do CC e do art. 14, § 4º do CDC. Pode ocorrer que do erro médico derive responsabilidade objetiva das clínicas e hospitais públicos (CF, art. 37, § 6º) e particulares (CDC, art. 14), mas a responsabilidade do profissional liberal será sempre fundada na culpa (STJ, 4ª T., REsp. 196.306, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julg. 03.08.2004, publ. DJ 16.08.2004). Não basta, portanto, que a conduta do profissional tenha causado um dano. Há que se identificar também o seu proceder culposo, mesmo que este não se relacione diretamente com o procedimento adotado no tratamento em si considerado" (Gustavo Tepedino e Milena Donato Oliva, Aspectos controvertidos sobre a responsabilidade médica)*" (Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República, Ed. Renovar, 2006, vol. II, p. 879).

Induvidoso, portanto, que muito embora a responsabilidade civil dos hospitais e planos de saúde seja de caráter objetivo (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), em casos de danos causados por erro médico a prova da culpa médica se faz imprescindível.

Em termos outros, a responsabilização civil dos réus na situação fática presente depende, necessariamente, da comprovação da culpa (negligência, imprudência e imperícia) do profissional médico que atendeu o primeiro autor para, somente então, ter-se por viabilizada a condenação pleiteada em Juízo.

Desta forma, a questão primordial reside justamente em estabelecer se houve má prática médica por parte do médico (ou corpo clínico) que atendeu o primeiro autor.

Tecidas as referidas considerações, observa-se da prova pericial encartada nos autos que a *expert* concluiu, de forma categórica, a inexistência de qualquer erro médico no atendimento dispensado à pessoa do autor, asseverando, em termos gerais, que a complicação vivenciada por ele decorre do próprio risco cirúrgico a que foi submetido.

De forma específica, o perito constatou que o primeiro autor se submeteu, em data de 20.01.2017, a cirurgia eletiva devido a ruptura de manguito rotador, assim o fazendo através procedimento por videoartroscopia de ombro.

Relatou, ainda, que na mesma data da cirurgia, horas depois de sua conclusão, o autor apresentou desconforto respiratório, além de dor na região

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 18/03/2024 às 11:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817442-06.2018.8.12.0001 e código q1BDz5bV.

torácica, de modo que a após a realização de exames foi constatado pela equipe médica a conformação de pneumotórax, sendo então encaminhado à UTI e submetido a procedimento de drenagem torácica direita que, por sua vez, solucionou a problemática vivenciada, seguindo-se a recuperação completa.

Esclareceu a médica perita nomeada por este Juízo que o quadro de pneumotórax desenvolvido pelo autor "*é definido como ar no espaço pleural, isto é, entre o pulmão e a parede torácica*" (f. 699) e, no caso analisado, foi por ela classificado como "pneumotórax adquirido", porquanto resultante de "*entrada de ar na cavidade pleural por um traumatismo ou de uma forma iatrogênica (no seguimento de diferentes procedimentos diagnósticos ou terapêuticos), levando a rotura do pulmão ou lesão da parede do tórax*" (f. 699-700).

Pontuou a perita, com bastante clareza, que o procedimento cirúrgico a que o autor foi submetido (videoartroscopia) consiste em técnica minimamente invasiva para pacientes com lesões do manguito rotador e que "*por mais raro que seja, complicações respiratórias, como pneumotórax, foram relatadas em pacientes submetidos à artroscopia do ombro*" (f. 701).

Nesta esteira, é possível observar que a lesão mencionada pelos autores é de possível ocorrência em procedimento cirúrgico como àquele a que se submeteu, muito embora comumente não ocorra. Cuida-se, portanto, de um risco cirúrgico a que o autor, à obviedade, não estava isento.

Destacou a perita, também, que *"ventilação assistida por pressão, bloqueio de plexo braquial, intubação e cirurgia podem estar relacionados a pneumotórax na cirurgia artroscópica do ombro"* (f. 701). Acrescentou, ainda, que "*a presença de pneumotórax após artroscopia do ombro pode ser principalmente atribuída à ruptura da pleura parietal, ruptura da pleura visceral e ruptura alveolar ou trauma durante a anestesia"* (f. 701), a evidenciar diversas variantes que podem advir da cirurgia de ombro realizada na pessoa do autor.

O trabalho técnico salientou que "*a causa do pneumotórax pode estar relacionado tanto ao procedimento anestésico de ventilação mecânica (barotrauma), quanto ao procedimento cirúrgico de artroscopia de ombro (ruptura pleural)*" (f. 701), ponderando que o "*pneumotórax por barotrauma surge em decorrência da pressão positiva a que os pulmões estão sendo submetidos*" (f. 700), depreendendo-se daí ser risco aceitável nesse tipo de procedimento médico-cirúrgico a complicação clínica, infelizmente, vivenciada pelo autor.

Ao tecer considerações acerca da cirurgia de videoartroscopia de ombro, a perita esclareceu o quanto adiante segue em seu laudo complementar de f. 751-764:

> *Os mecanismos propostos que se enquadram no caso em questão estão relacionados a ventilação mecânica ou artroscopia do ombro. O mecanismo de pneumotórax relacionado a ventilação mecânica seria por barotrauma decorrentes de pressão transpulmonar aumentada. Todos os pacientes em ventilação mecânica correm o risco de barotrauma, particularmente aqueles com pressões de platô elevadas > 35 cmH2O. O próprio histórico de via aérea difícil aumenta o risco de barotrauma, seja pelo risco de intubação e ventilação seletiva em pulmão direito, ou por ventilação com alta pressão*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 18/03/2024 às 11:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817442-06.2018.8.12.0001 e código q1BDz5bV.

> *com dispositivo ambu/máscara. Seria como o romper de uma bexiga quando a quantidade de ar ou seu conteúdo supera sua capacidade de distensão.* ***A artroscopia do ombro requer distensão contínua com pressão líquida a fim de proporcionar hemostasia adequada e permitir a visualização. Algumas teorias são propostas para explicar a formação de pneumotórax em artroscopia de ombro. Uma delas seria associada ao extravasamento de ar que pode ser aspirado do portal lateral quando a bomba de infusão artroscópica e o power shaver com sucção são ligados. Outra seria distensão por suspensão hídrica (coluna d'água) ou através de bomba de pressão articular e sucção contínua relacionada a distensão subacromial. Outro mecanismo ainda, seria o próprio trauma Artroscópico***. (f. 760) (grifei).

Decorre do excerto acima transcritos algumas complicações factíveis que podem surgir do procedimento cirúrgico a que foi submetido o autor, reforçando a ideia de risco admitido na espécie, a afastar a configuração de erro médico.

E não é tudo.

Os autores tenderam a imputar erro médico na conduta do anestesista responsável pela intubação do autor no momento cirúrgico, o que também foi descartado pela *expert* em seu trabalho técnico.

Vê-se que a *expert* foi enfática ao destacar que a intubação do autor não revelou qualquer equívoco médico, tanto que a tese ventilada na inicial de que a lesão pulmonar seria decorrente da utilização de tubo inadequado - maior que o tamanho do esôfago do paciente - foi por ela completamente rechaçada.

A propósito, consta da resposta ao quesito "6" à f. 704:

> 6- **Segundo a Autora, uma enfermeira a informou que a perfuração do pulmão do Autor ocorreu pela utilização de um tubo inadequado – maior que o tamanho do esôfago do paciente– durante a entubação. O Sr. Perito poderia esclarecer/explicar deque forma a perfuração do pulmão ocorreu, e se a perfuração decorreu do uso inadequado do equipamento médico (imperícia e imprudência)?**
> O tubo orotraqueal é colocado na traquéia e não no esôfago. Os números dos tubos apresentados no prontuário são compatíveis com o uso em homens adultos (7,5 e 8,0), portanto, adequado para o caso em questão. A perfurão, provavelmente ocorreu por barotrauma ou devido a compressão/ descompressão pleural durante artroscopia.

Tem-se, assim, não ser aceita a tese autoral no sentido de ter havido falha médica no momento de intubação do autor, circunstância que endossa a improcedência dos pedidos iniciais.

Questionaram, ainda, os autores, à f. 759, se seria "*possível atribuir à lesão pulmonar à provável inexperiência ou erro técnico do médico anestesista para a realização do procedimento de intubação orotraqueal ou preparação inadequada do paciente?"*, esclarecendo a perita o seguinte, de forma claramente negativa:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 18/03/2024 às 11:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817442-06.2018.8.12.0001 e código q1BDz5bV.

> Em Folha de consulta pré anestésica de 22/11/2016 realizada pelo Dr Paulo Henrique Mariano há descrição de obesidade, o que é um fator de risco importante para via aérea difícil. Os mecanismos propostos para o pneumotórax durante o ato anestésico do caso em questão não estão relacionados a perfuração direta, conforme ampla explanação na discussão desta perícia. A anestesia é a área médica que se encontra mais preparada para o manejo de via aérea. Os protocolos de manejo de via aérea difícil, seguidos por todos os profissionais médicos são especialmente oriundos de esforços das sociedades de anestesia, em especial a Sociedade Americana de Anestesiologia-ASA (*American Society of Anesthesiology).*

E acrescentou em novo laudo complementar à f. 804:

> orotraqueal. O procedimento de intubação orotraqueal do caso em questão foi realizado por um médico anestesista. Não há no prontuário nenhuma descrição que caracterize inexperiência ou erro técnico do médico anestesista para a realização do procedimento de intubação orotraqueal ou preparação inadequada do paciente.

Induvidoso, portanto, a inexistência de erro médico capaz de autorizar o acolhimento do édito condenatório pretendido por meio desta demanda, uma vez que ao autor foram prestados assistência e tratamento médico adequado.

Em outros termos, as complicações que surgiram do procedimento médico-cirúrgico trazido à apreciação jurisdicional são descritas como indesejadas, porém, de possível ocorrência e que, infortunadamente, acometeu o primeiro autor.

A este respeito, pontificou a perita à f. 806:

> *Se intercorrência se entende por algo fora do comum, fora do esperado, houve sim uma intercorrência. O pneumotórax não é o esperado para a maioria das cirurgias de artroscopia de ombro, porém está descrito na literatura médica como uma complicação.*
>
> *Os médicos possuem obrigação de meio, devendo empregar todos os esforços, procedimentos e diligências necessários ao paciente, contudo, se o resultado não for exatamente o esperado, não há que se falar em erro médico.*
>
> *O entendimento de "sucesso" do procedimento depende de vários fatores, a depender de quem está analisando. O mesmo caso em tela poderia ser considerado um sucesso por um individuo que tem seu ombro com as funções restituídas e seu pulmão sem sequelas.*

Se isso não bastasse, calha ressaltar que a complicação clínica do autor (pneumotórax) pode se dar inicialmente de forma assintomática, tanto que não

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 18/03/2024 às 11:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817442-06.2018.8.12.0001 e código q1BDz5bV.

somente foi identificada pelos réus após a constatação de dificuldades respiratórias pelo autor.

Esclareceu a perita do Juízo não haver "*correlação específica entre o tempo decorrido entre o evento que causou o pneumotórax e a manifestação de sintomas clínicos, sendo que, em alguns casos, mesmo em ventilação mecânica, os casos de pneumotórax podem ser assintomáticos (pneumotórax oculto). O periciado em questão provavelmente adquiriu (ou seja, não foi espontâneo) o pneumotórax durante a cirurgia (relacionado a artroscopia ou a procedimento anestésico) e o pneumotórax foi progredindo em tamanho até se tornar sintomático e hipertensivo. O próprio pneumotórax hipertensivo, embora possa surgir após um pneumotórax espontâneo, é mais frequente após um pneumotórax adquirido*" (f. 754).

Fato é que, ao constatar a complicação amplamente debatida nestes autos, recebeu o autor o atendimento escorreito e tempestivo, tanto que a recuperou plenamente sua saúde, sem suportar qualquer sequela.

Neste sentido, aliás, concluiu a perita, de forma categórica e assertiva, não haver demonstração de conduta imprudente, negligente ou imperita por parte dos réus, quando do laudo inicial (f. 701). Veja-se:

> **6- CONCLUSÃO**
>
> Pelo apresentado, o periciado apresentou pneumotórax relacionado ao procedimento cirúrgico, sem sequelas aparentes. Não há elementos que possam ser relacionados a imprudência, negligência ou imperícia da equipe ou local em que foi prestado o atendimento.

Esta conclusão foi reforçada, uma vez mais, quando do laudo completar, o que é extraída da f. 802:

> **4- CONCLUSÃO**
>
> Pelo apresentado podemos concluir que o periciado apresentou pneumotórax **ADQUIRIDO** (iatrogênico ou traumático) como **COMPLICAÇÃO** de um procedimento cirúrgico. **NÃO HÁ ELEMENTOS** que possam ser relacionados a imprudência, negligência ou imperícia da equipe ou local em que foi prestado o atendimento.

Vai daí que por todos os lados que se analisa a questão trazida à apreciação jurisdicional, a improcedência revela ser medida de rigor, na medida em que não houve identificação robusta de qualquer conduta ilícita imputada aos réus.

Em casos análogos, extrai-se da jurisprudência pátria, inclusive do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul:

> *APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE **ERRO MÉDICO** COM PENSÃO VITALÍCIA – CONDUTA ILÍCITA DOS PROFISSIONAIS NÃO DEMONSTRADA – **LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVOS APTOS A AFASTAR A CREDIBILIDADE DAS CONSTATAÇÕES FIRMADAS PELO PERITO – DESCABIMENTO DA***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 18/03/2024 às 11:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817442-06.2018.8.12.0001 e código q1BDz5bV.

> ***RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL*** *– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não provado pela parte autora a alegada falha e inadequação da conduta médica, a caracterizar o ato ilícito, rompe-se o nexo de causalidade, o que acarreta a improcedência dos pedidos indenizatórios.* ***Em demanda que visa o reconhecimento de erro médico, imprescindível a realização de perícia judicial, diante da necessidade de se considerar conhecimentos técnicos, cabendo à parte que impugna o respectivo laudo provar as causas que retirem sua idoneidade e credibilidade, a fim de afastar as conclusões do perito***. (**TJMS**. Apelação Cível n. 0059980-79.2011.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 31/05/2021, p: 09/06/2021) (grifei).
>
> *APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA D REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS -* ***ERRO MÉDICO - PROVA PERICIAL CONCLUINDO QUE OS PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL FORAM ADEQUADOS DIANTE DO QUADRO CLÍNICO - REJEIÇÃO DAS INDENIZAÇÕES, CONFIRMADA*** *– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Confirma-se a sentença, negando-se provimento ao recurso de apelação, ante a improcedência dos pedidos de indenizações morais, materiais e estéticos por erro médio, se a perícia judicial concluiu que os procedimentos médicos realizados no hospital foram adequados, diante do quadro clínico do paciente e que quanto ao dano estético sofrido pelo requerente, não possui ele nexo de causalidade com a atuação médica dos recorridos.* (**TJMS**. Apelação Cível n. 0814989-14.2013.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 17/09/2020, p: 22/09/2020) (grifei).

Desta forma, como não há demonstração cabal de que tenha havido erro médico na hipótese sob exame, a improcedência dos pedidos condenatórios é medida de rigor.

Nem se diga que a prova oral seria capaz de desmerecer a conclusão pericial, notadamente porque nenhuma das testemunhas arrolados pelos autores às f. 662-663, detém expertise médica para desconstituir o laborioso trabalho técnico contido nos autos.

Ressalta-se, ainda, que não está este Juízo a desmerecer os momentos de angústia vivenciados pelos autores.

Em verdade, as complicações médicas decorrentes do ato cirúrgico certamente geraram apreensão e sentimento de impotência, além da notável aflição ante o quadro incerto e desconhecido que se descortinou na hipótese vertida nestes autos, fazendo emergir sentimentos de medo, angústia e perturbação emocional e psicológica em ambos os autores.

Contudo, apesar de todos os sentimentos negativos acima referenciados, o conjunto probatório revelou, de forma bastante satisfatória, que as intercorrências vivenciadas pelo primeiro autor, embora não desejadas, eram passíveis de acontecer, conforme literatura médica e, felizmente, foram contornadas a tempo de impedir qualquer resultado trágico e irreversível.

Registre-se, por fim, que foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 18/03/2024 às 11:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817442-06.2018.8.12.0001 e código q1BDz5bV.

precedentemente, razão pela qual se afigura observada a regra prevista no artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ante o todo exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES, nos termos da fundamentação supra, os pedidos deduzidos na petição inicial.

Diante do princípio da sucumbência, condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais (incluída a remuneração do perito), além de honorários advocatícios em favor dos patronos adversos, os quais, considerando a singeleza da causa e do trabalho desenvolvido, o tempo exigido para tal desiderato e que o serviço foi prestado no mesmo local de seu domicílio, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2.º, do Código de Processo Civil).

Julgo resolvido o mérito da causa na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará em favor da perita, se isso ainda não ocorreu, a fim de que ela proceda ao levantamento da verba honorária que lhe foi arbitrada e depositada nos autos. Diligências de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Campo Grande, data da inclusão no sistema.

Deni Luis Dalla Riva
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENI LUIS DALLA RIVA, liberado nos autos em 18/03/2024 às 11:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817442-06.2018.8.12.0001 e código q1BDz5bV.